

Datos Personales							
Nombre:	ALDERSON GOMEZ LOAIZA	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	1983-09-10	Edad	42 Años, 7 Meses, Y 3 Días
Identificación:	CC - 7574079	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ADMINISTRADOR DE EPRESA
Correo Electrónico:	Aldersongomez@gmail.Com - 7574079			Dirección:	Cra 9 # 16b-21 Barrio Centro		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						

Apertura psicología del 2026-03-26 00:07:18: 42 años, 7 meses, y 3 días

DATOS GENERALES

Remisión

Autorreferido (Particular)

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

“Yo tengo ya 42 años y siento que es necesario tocar esa pueta del tema de la terapia” “Hay algo que me inquieta no se si yo estoy teniendo fallas, y eso produce que me cuestione, será que tengo que cambiar, que mejorar” “Son varios aspectos, económicos, personales”.

Enfermedad Actual

Paciente refiere inicio de sintomatología física en el mes de diciembre dde 2025, caracterizada por episodios de sensación de asfixia, tos intensa hasta el punto de generar cierre de la vía respiratoria y emesis asociada. En este contexto, inició proceso de valoración médica en Neurocenter, donde se identificó desviación de cornete nasal con obstrucción de la vía respiratoria. También refiere matrimonio previo a los 31 años, con posterior divorcio a los 36 años debido a situaciones de infidelidad y falta de comunicación asertiva. Actualmente, se encuentra en una relación de unión marital de hecho desde hace aproximadamente tres años con una pareja 11 años menor, en la cual se evidencian dificultades significativas en la comunicación asertiva y la convivencia. El paciente describe a su pareja como impulsiva y con reacciones desproporcionadas ante situaciones conflictivas. Manifiesta que la relación se encuentra en distanciamiento desde hace aproximadamente dos meses y medio. Señala que los conflictos se intensificaron cuando su pareja expresó el deseo de formalizar la relación mediante matrimonio, propuesta frente a la cual el paciente mostró resistencia, asociada a experiencias negativas previas. A partir de este evento, refiere que su pareja inició comparaciones con su relación anterior, lo que incrementó la tensión en la dinámica relacional. Actualmente, el paciente expresa cambios en su vínculo afectivo, describiendo una disminución en la expresión emocional y afectiva (caricias, besos), así como una percepción de distanciamiento emocional, refiriendo que ya no percibe a su pareja de la misma manera.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

Apèndice

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

TAC

Patología

No Refiere

Tóxicos

Medicación

No Refiere

Hospitalizaciones

Si, Por Alergia A Camarones.

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión

Tía Materna

Demencia

No Refiere

Drogadicción

No Refiere

Patológicos

Cáncer

Ansiedad

No Refiere

Alcoholismo

No Refiere

Discapacidad Intelectual

No Refiere

Otros

No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

El paciente cuenta con formación profesional en Administración de Empresas; refiere haber mantenido, a lo largo de su trayectoria académica, adecuadas relaciones interpersonales, destacándose por una interacción social funcional y adaptativa en contextos educativos.

Historia laboral

Refiere que actualmente lidera procesos de emprendimiento en los municipios de La Paz, San Diego, Manaure y Pueblo Bello; asimismo, es propietario de la óptica Tesoro y desarrolla actividades en el sector ganadero. En el ámbito laboral, reporta mantener adecuadas relaciones interpersonales y un funcionamiento ocupacional estable.

Historia familiar

Actualmente convive con su madre, la señora Yolanda Loaiza, de 60 años, y su hermana Maira Alejandra Gómez, de 37 años, con quienes mantiene dinámicas familiares estables; destaca una relación cercana y satisfactoria con la madre, mientras que con la hermana se encuentra en proceso de fortalecer la comunicación asertiva. En cuanto a su núcleo familiar propio, señala que se encuentra temporalmente separado de su pareja, la señora Paola Ramirez, de 32 años, con quien tiene un hijo Vicente Gómez, de 1 año y 4 meses, refiriendo que, pese al distanciamiento actual, se encuentran en proceso de mejorar la comunicación.

Historia social

Refiere que mantiene un estilo de vida social moderado, indicando que limita sus salidas con el fin de evitar gastos innecesarios; no obstante, comparte con un grupo cercano de amigos en espacios específicos, con quienes sostiene vínculos estables. Se describe con adecuadas habilidades sociales, señalando que se integra con facilidad y participa en reuniones sociales. Asimismo, reporta haberse vinculado recientemente a actividades de una iglesia cristiana, con el propósito de fortalecer su dimensión espiritual, en el contexto de situaciones emocionales asociadas a su historia de pareja.

Historia emocional/afectiva

Describe como una persona poco expresiva en el plano afectivo, manteniendo un estilo relacional más centrado en la cordialidad y la amabilidad que en la manifestación abierta de afecto. En la actualidad, refiere desacuerdos con su pareja asociados a expectativas frente al proyecto de vida, específicamente en relación con el matrimonio y la adquisición de vivienda, aspectos frente a los cuales el paciente expresa desacuerdo, considerando que la inversión en vivienda podría ser destinada a otros proyectos de tipo económico.

Historia deportiva

Señala que no realiza actualmente ninguna práctica de actividad física estructurada. Sin embargo, inicio GYM hace un mes.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se ha realizado proceso de evaluación psicológica inicial a través de entrevista semiestructurada, observación directa y uso de diálogo socrático, orientados a la exploración de la sintomatología actual, dinámica relacional y estilos de afrontamiento. El paciente se presenta con adecuado nivel de introspección, pensamiento lógico-analítico y discurso coherente, evidenciando una tendencia a la racionalización de sus experiencias emocionales. Dado el corto tiempo de intervención (dos sesiones a la fecha), la información recogida se considera preliminar, por lo cual se hace necesario profundizar mediante la aplicación de instrumentos psicométricos y proyectivos que permitan una valoración más integral del funcionamiento emocional, cognitivo y relacional del paciente, así como una mayor precisión en la formulación clínica.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

No refiere

Otras intervenciones

No refiere

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente que ingresa a consulta con adecuado salud y presentación personal acorde al contexto. Se encuentra alerta, atento y colaborador durante la entrevista. Presenta lenguaje verbal fluido, coherente y organizado, con pensamiento lógico, estructurado y con predominio de racionalización. Se encuentra orientado en las tres esferas (autopsíquica, alopsíquica y temporoespacial), con memoria conservada y adecuado nivel de atención (euprosexia). A nivel afectivo, se observa modulación emocional restringida, con baja expresividad afectiva. El paciente se muestra consciente de su proceso psicológico y receptivo a la intervención. No se evidencian alteraciones en la sensopercepción (niega alucinaciones), ni presencia de ideas delirantes. Niega ideación suicida o autolesiva. Juicio y capacidad de introspección conservados.

Ciclos del Sueño

Duerme 6 horas, a veces con interrupciones.

Apetito

Coservado

Actividades de Autocuidado

Conservado

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F41.9 - OTRO TRASTORNO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

F419 - TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO Impresión Diagnóstica Relacionada 2 NREF - NO REFIERE
Establecido por primera vez Si
Objeto de atención clínica No refiere

PLAN DE INTERVENCIÓN
Plan de Intervención
Objetivo General Favorecer el reconocimiento, expresión y regulación de los estados emocionales del paciente, disminuyendo la sintomatología somática asociada y fortaleciendo estrategias de afrontamiento adaptativas en el contexto personal y relacional.
Objetivos Específicos - Identificar y diferenciar los estados emocionales propios, reduciendo el predominio de la racionalización como principal estrategia de afrontamiento. - Fortalecer habilidades de comunicación asertiva y manejo de conflictos en el contexto de pareja, promoviendo una toma de decisiones consciente frente a su proyecto de vida.
Sugerencias e Interconsultas Se sugiere mantener seguimiento médico por especialidad correspondiente (otorrinolaringología), con el fin de dar continuidad al manejo de la condición respiratoria identificada (desviación de cornete nasal). Asimismo, se recomienda valoración médica complementaria en caso de persistencia o incremento de la sintomatología física, con el objetivo de descartar etiología orgánica adicional.
Observaciones y Recomendaciones OBSERVACIONES: El paciente presenta un estilo de afrontamiento predominantemente racional, con tendencia a analizar las situaciones desde lo cognitivo, evidenciándose limitaciones en el reconocimiento y expresión de sus estados emocionales. Se identifican dificultades en la comunicación afectiva dentro del contexto de pareja, así como evitación frente a situaciones que implican compromiso emocional. La sintomatología física referida parece estar asociada a momentos de mayor carga emocional, particularmente en relación con conflictos relacionales actuales. Se sugiere continuar profundizando en el proceso evaluativo para una mejor comprensión del funcionamiento emocional y relacional del paciente. RECOMENDACIONES: - Continuar proceso de evaluación psicológica con el fin de profundizar en la estructura de personalidad, estilos de afrontamiento y posibles esquemas disfuncionales. - Iniciar proceso terapéutico orientado al reconocimiento, expresión y regulación emocional, con énfasis en la disminución de la racionalización como estrategia predominante. - Implementar estrategias de regulación fisiológica (ej. respiración diafragmática) para el manejo de la sintomatología somática asociada. - Fortalecer habilidades de comunicación asertiva y manejo de conflictos en el contexto de pareja. - Promover espacios de reflexión orientados a la toma de decisiones conscientes frente a su proyecto de vida y relaciones afectivas. - Fomentar la práctica regular de actividad física o deportiva de interés personal, como estrategia de regulación emocional, disminución del estrés y promoción del bienestar general.

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU